

Les blocs périmédullaires chez l'adulte

Question 9 — Terrain cardiovasculaire

Périmètre limité — installment 5/n : ce document source compte 15 « Questions » cliniques et 369 citations de grade au total. Cette fiche couvre INTÉGRALEMENT les Questions 9 (terrain cardiovasculaire) et 10 (terrain respiratoire) — les deux premières d'une série de 5 « Questions terrain » consécutives (9 à 13). Les Questions 11-13 (hémostase, neurologique, infectieux — nettement plus volumineuses) et 14-15 (gestion de l'échec, facteurs de risque de complications) ne sont PAS couvertes ici — installments futurs. Les Questions 1-2, 3-5, 7 et 8 sont couvertes par des fiches séparées ; la Question 6 est exclue (superseded par une fiche HAS 2025).

Grille EBM classique — **A** : essais randomisés de forte puissance/méta-analyses ; **B** : essais randomisés de faible puissance/études de cohorte ; **C** : cas-témoins/études rétrospectives ; **AE** : accord professionnel. Aucune citation « grade D », « consensus professionnel » ni « avis d'experts » dans ce périmètre. Fiche limitée aux Questions 9-10/15 du document (terrains cardiovasculaire et respiratoire).

Question 9 — Anesthésie périmédullaire et pathologie cardiovasculaire

Catégorie	Recommandation	Grade
Effets hémodynamiques	Effets proportionnels à l'étendue du bloc sympathique : vasodilatation veineuse prédominante (↓retour veineux, ↓débit cardiaque, hypotension dans 15-50 % des cas) et bradycardie (atteinte des fibres cardioaccélétratives) ; effets limités si le bloc reste sous T11, importants entre T6-T11, majeurs au-delà de T6 ou si une AG est associée (hypotension et bradycardie associées dans 1/4 des cas).	B
Prévention/traitement	Remplissage vasculaire + vasoconstricteur (éphédrine ou phényléphrine) ; les solutions colloïdes sont plus efficaces que les cristalloïdes.	C
HTA	Arrêter un traitement inhibiteur du système rénine-angiotensine (IEC/ARA2) en préopératoire (pas d'effet rebond à l'arrêt).	B
HTA	Administer un vasoconstricteur pour compenser les effets de l'APM (bolus d'éphédrine 3 mg ou de phényléphrine 0,25 mg) ; la terlipressine a été proposée mais avec un risque connu d'accident coronarien.	C
HTA	L'APM est contre-indiquée en cas d'HTA mal contrôlée, instable, sévère (PAD > 110 mmHg) ou maligne, et en cas d'urgence en dehors d'un contexte obstétrical.	C
Coronarien	Le blocage sympathique a des effets bénéfiques chez le coronarien instable (via l'analgésie postopératoire induite), mais le risque d'ischémie myocardique augmente si le bloc est étendu, si une AG est associée, ou lors d'APM lombaire (tonus sympathique thoracique augmenté).	B
Coronarien	Un traitement bêta-bloquant pris au long cours n'aggrave pas le risque coronaire.	C
Insuffisance cardiaque	Les objectifs thérapeutiques du traitement de l'insuffisance cardiaque (IEC, ARAII, bêta-bloquant) visent l'augmentation de la fraction d'éjection par vasodilatation artérielle et la diminution des effets sympathique/SRA — aucun travail n'a étudié les effets d'une APM chez les patients traités par ces médicaments.	A
Insuffisance cardiaque	En cas de cardiopathie dilatée, la baisse de la postcharge du VG induite par l'APM peut améliorer le volume d'éjection systolique malgré une diminution de la précharge ventriculaire.	C
Cardiopathie hypertrophique	Il est possible d'utiliser l'APM, notamment lors de césarienne, malgré le risque d'hypotension induit par la diminution de la précharge ventriculaire.	AE
Valvulopathie sténosante	Les APM sont en principe contre-indiquées.	C
Troubles du rythme	Chez le patient traité par un antiarythmique, préférer la lidocaïne aux autres AL administrés en péridurale (la ropivacaïne et la lévobupivacaïne sont moins arythmogènes que la bupivacaïne).	C

Précision du source : en cas de valvulopathie régurgitante, le risque de l'APM est superposable à celui des patients insuffisants cardiaques (non gradé).

Les blocs périmédullaires chez l'adulte

Question 10 — Terrain respiratoire & sources



Question 10 — Anesthésie périmédullaire et pathologie respiratoire

Catégorie	Recommandation	Grade
Effets respiratoires	Peu importants chez le sujet normal, mais peuvent être amplifiés par l'administration concomitante de sédatifs.	A
Asthme	L'APM est recommandée chez l'asthmatique : elle évite l'intubation trachéale et ne modifie pas le seuil de réactivité bronchique.	C
Altération ventilatoire	Chez les patients présentant une altération de la dynamique ventilatoire ou une sécrétion bronchique importante, éviter la paralysie des muscles respiratoires accessoires (risque d'encombrement bronchopulmonaire, d'atélectasie, d'infection) ; associer un AL à faible concentration et un opiacé (réduit les effets moteurs des AL) — solution analgésique de choix.	C
SAOS	Risque accru d'intubation difficile et sensibilité particulière aux effets dépresseurs des agents anesthésiques.	A
SAOS	L'APM sans opiacé est une technique recommandable, en évitant l'administration d'agents dépresseurs du système nerveux central.	C
Surveillance	Doit être assurée par du personnel formé, dans des unités spécialisées selon l'état du patient et la voie d'administration ; un protocole de surveillance et de traitement des complications doit être écrit et disponible pour tout le personnel prenant en charge les patients.	A

Repères pratiques non gradés :

- Durée de surveillance minimale : 24h après la dernière injection intrathécale de morphine, 6h après celle d'un opiacé liposoluble.
- Contenu de la surveillance : état de conscience, étendue du bloc sensitif, en plus des paramètres vitaux habituels.

Sources et avertissement

Document source : SFAR/Sofcot/Sofmer, « Les blocs périmédullaires chez l'adulte », Recommandations pour la Pratique Clinique, présentées le 24 septembre 2005 (47e congrès SFAR), Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation 26 (2007) 720-752.

URL source : <https://sfar.org/les-blocs-perimedullaires-chez-ladulte/>

Couverture : Questions 9-10/15 uniquement (terrains cardiovasculaire et respiratoire) — 18 recommandations gradées (A:4, B:3, C:10, AE:1). Les Questions 11-13 (hémostasie, neurologique, infectieux) et 14-15 (échec, facteurs de risque) ne sont pas couvertes ici — hors périmètre de cette fiche, installments futurs. Argumentaire scientifique détaillé (document source complet) non reproduit.

Avertissement : cette fiche est une synthèse indépendante et PARTIELLE (Questions 9-10 uniquement, sur 15). Elle ne remplace pas le texte intégral — en particulier pour les terrains hémostasie/neurologique/infectieux, la gestion de l'échec, ou les facteurs de risque de complications. Cette fiche n'est ni éditée ni validée par la SFAR.